



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : عواطف محمد نبيل ابراهيم

العنوان : الجيزة

الحي / المدينة : الهرم

المحافظة : الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 19-09-2026

رقم البطاقة : 29312011706127 رقم التليفون : 01127798634

العمر (تاريخ الميلاد) : 01-12-1993 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

قسم العلاج :
الاورام

خطه العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للرقبة والصدر والبطن والحوض
بالصبغة [11128]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / / د. / / د. / / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطه العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: عواطف محمد نبيل ابراهيم National ID: 29312011706127	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدى و تحتاج الى Contrast-enhanced CT of neck, chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

عواطف
محمد نبيل ابراهيم محمد
مساكن المعهد الدينى
بنى سويف - بنى سويف

١٩٩٣/١٢/٢١ ٢٩٣ ١٢ ٠١ ١٧ ٠٦١ ٢٧

IL4968235

٢٠٢٠/٠٧/١٥ ٢٩٣ ١٢ ٠١ ١٧ ٠٦١ ٢٧

ربة منزل
أنثى
اسلام حسين مصطفى حسين
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠٧/١٥

٦



Patient Name	: الأستاذة / عواطف محمد نبيل ابراهيم	Request No.	: 13003001
Patient No.	: 29312011706127	Request Date	: 11/01/2025
Path No.	: 124/25	Verification Date	: 30/01/2025
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادئه
Age	: 31 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data: Left breast cancer, post NACT .&right breast lesion

Nature of specimen:left BCS&SLNB&Right side excision biopsy

Gross examination

• Procedure: Left BCS

Fibrofatty tissue piece measured 18x13x3 cm with covering skin ellipse measured 18x1.5 cm

• Tumor extent : A greyish white tumour bed site

• Size:Four wired areas :1)1st wired area 2x1x1 cm

2)1x1x0.5 cm

3)0.5x0.5x0.5 cm

4)0.8x0.5x0.5 cm

• Skin involvement: Unremarkable grossly .

• Distance from margins: 0.5 cm away from least margin

-Right side excision biopsy : fibrofatty tissue piece measured 4x2.5x1 cm , cutsection showed grey white rubbery area measured 1.5x1.5x1 cm least margin 0.2 cm

• Frozen section:- Free margins of left side /free (0/4) lymph nodes

-Free margins of right side

Microscopic examination:

• Histological type: Invasive duct carcinoma (Cellularity 30%)

• Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G III(3+2+3)

• Ductal carcinoma in situ: Positive (10%)

• Skin involvement: Free

• Resection margins: Free margins except deep margin (positive for DCIS) ←

• SLNB :free (0/5) ←

• Histologic response to therapy: Pathologic partial response

Verified by :

Dr.Heba Hasan





Patient Name	: الأستاذة / عرافة محمد نبيل ابراهيم	Request No.	: 13003001
Patient No.	: 29312011706127	Request Date	: 11/01/2025
Path No.	: 124/25	Verification Date	: 30/01/2025
Sex	: Female	Financial Category	: ميانره - اورام دار السلام
Age	: 31 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

-Right side :

Microscopic examination revealed breast tissue showing diffuse stromal fibrosis and focal adenosis. Some of the proliferating ducts are irregularly dilated. The ducts are lined by inner columnar and outer myoepithelial cells . No atypia or malignancy in sections examined.

Diagnosis:

Left BCS (post NACT) :

Invasive duct carcinoma grade III (CELLULARITY 30 %)

- Free margins
- Pathologic partial response (PPR)
- Free SLNB(0/5)
- Stage : ypT2,ypN0
- RCB : 1.93 , RCB class II

Comment : There is disparity between frozen and paraffin results , However the final diagnosis depend on the paraffin results due to error in block quality.

-Right side :excision biopsy :

-Adenosis

-No Invasive tumor or DCIS

-Margins were free

Prof. Dr. Gamal Abdelatty
Dr.Nermin mohamed

Verified by :
Dr.Heba Hasan





Patient Name: Awatef Mohamed Nabil Ibrahim Mohamed	Date : 30/05/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 30 Year(s)
Medical ID: 1714/2024	Pat. ID: 53737

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. Chest:

- Left breast irregular speculated mass lesions the largest one measuring 2.4 x 2.6 cm.
- Left axillary level I and II pathologically enlarged lymph nodes the largest measures 1.4 x 2 cm.
- Right oblique fissural based micro-nodule measuring few mms.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size with homogenous CT texture. No focal lesions upon non contrast basis.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

3. The scanned skeleton:

- The scanned skeleton shows L4 lytic lesion measures 9 mm.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.



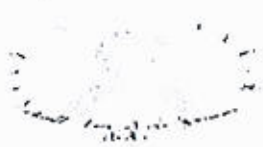
Patient Name: Awatef Mohamed Nabil Ibrahim Mohamed	Date : 30/05/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 30 Year(s)
Medical ID: 1714/2024	Pat. ID: 53737

OPINION:

- *Left breast malignant looking mass lesions with pathological ipsilateral axillary lymph nodes as described.*
- *1.4 lytic lesion for bone scan correlation.*
- *No pulmonary metastatic disease.*
- *No hepatic focal lesions upon non-contrast basis.*

Dr. Wafaa Ali, MSc.

Dr. Amr Farouk M.D.



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Family Welfare

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والعائلة



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : عواطف محمد ثبيل ابراهيم

Sex:

3- Medical number:
Female

83210069

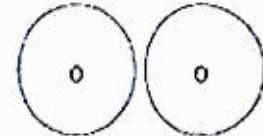
Old Med:

Old Med:

1714/2024

2-ID number:

Patient Age : 31 Y



Family history

Family history
-VQ

Phone

Phone

01127798634

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT
Breast

Marital status

Marital status
Married

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

10/02/2025

Co morbidity

Co Morbidity
hypothyroidism

Menopausal
status

Menopausal status
Pre-menopausal

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

Multicentric LY breast malignant mass + LT axillary LN (BIRADS 5)
RT Breast UOQ of focal asymmetry (BIRADS 3)

Mets Workup :

CTCAP FREE

BX IDC Ex COMMENT	ER 7/8 Ex COMMENT	PR 5/8 Ex COMMENT	Her 2 Neu 0 Her 2 Neu COMMENT	SISH Ex COMMENT	Ki67 45
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------	------------

T CT2 MULTI CENTERIC	N 1	M 0
-------------------------------	--------	--------

Sonomammography

cesm:lt breast multiple masses LOCATED AT UPPER OUTER QUADRANT TO LOWER OUTER QUADRANT
FROM 2 TO 5 CLOCK with suspicious enhancement with ipsilateral axillary lymphadenopathy
BIRADS vi

PATIENT HISTORY

pt ended 4 AC+4 taxotere 2/12/2024
last mdt:LT BCS WIRE LOCALIZATION AND SLNB:ypt2 NO
In 0/5

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

ADJUVANT ZOLADEX ARIMIDEX
PORT
ZOMETA/6MONTHS AFTER DENTAL EXAM

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

PATIENT NAME: AWATEF MOHAMMED NABIL IBRAHIM
GENDER: Female
DATE : 25-Jun-2024 01:01 PM

PATIENT ID: 10124243955
AGE: 30 y
ORDER: 2903731,2904637

CONTRAST ENHANCED SPECTRAL MAMMOGRAPHY

INDICATION:

- Left breast pathologically proven IDC grade II to exclude multicentricity

TECHNIQUE:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography CC and MLO views
- IV non-ionic contrast medium infusion 100 ml of ultravist

REPORT:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography showed minimal symmetrical background parenchymal enhancement.
- Left breast UOQ irregular masses showing moderate heterogenous mass enhancement with intervening pathological parenchyma non mass enhancement, the largest measured 2.5 x 3.6cm, being 4.4 cm from the nipple in CC view.
- Complementary left breast US revealed multiple irregular hypoechoic masses extending from 2 to 4-5 o'clock, the largest measuring about 2.1 x 2.4 cm.
- No right breast mass or non mass enhancement.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.
- Enlarged left axillary level I lymph nodes (about 3) showing non-uniform cortical thickening, the largest measuring about 1.3 x 2.2 cm with cortical thickening about 6 mm.
- Prominent right axillary level I lymph nodes showing diffuse cortical thickening reaching about 3.5 mm.

OPINION:

- left breast multiple masses with suspicious enhancement with ipsilateral axillary lymphadenopathy (BIRADS VI).
- No right breast pathological mass or non mass enhancement (BIRADS 1)

Reported By,

Dr. Fifi Sami, MSc

25-Jun-2024 01:22 PM

